

SISTEMA INTELIGENTE DE CARTERA E.S.E. (SIC-ESE)

Especificación Técnica y Funcional para la Gestión de Cartera en Primer Nivel de Atención

ENTIDAD DESTINO

Empresa Social del Estado (E.S.E.) - Manizales,
Caldas

DISEÑO DE ARQUITECTURA Y NEGOCIO

Jefatura de Cartera de Alto Nivel

El sector salud en Colombia, específicamente en el **primer nivel de atención**, presenta los mayores desafíos de liquidez debido a la alta dispersión de la contratación, el flujo fragmentado de recursos (ADRES, cuentas maestras territoriales) y la severidad del proceso de glosas. Este documento técnico define la estructura de datos, requerimientos analíticos y la visualización de un **Dashboard Gerencial de Cartera**, diseñado para mitigar el riesgo de pérdida de valor del recaudo y garantizar el cumplimiento ante entes de control (Superintendencia Nacional de Salud, Contraloría, Ministerio de Salud).

Propósito Estratégico del SIC-ESE

Habilitar un monitoreo dinámico y en tiempo real de los saldos facturados, conciliados y en glosa, con un enfoque predictivo basado en semáforos de vencimiento e historial de cobro coercitivo, persuasivo y administrativo, permitiendo a la gerencia sustentar la solidez financiera ante cualquier auditoría.

1. Módulos Clave & Dashboard Gerencial

RECAUDO ESTIMADO	CARTERA CORRIENTE	GLOSA HISTÓRICA	DÍAS DE ROTACIÓN
\$1,240 M	42%	3.8%	74 Días

A. Segmentación de Cartera por Edades (Normativa Circular Única Supersalud)

La segmentación temporal es vital para la provisión de cartera según los estándares contables bajo NIIF para el sector público. El sistema agrupa los saldos automáticamente en los siguientes rangos de maduración:

- **0 a 30 días (Corriente):** Facturación en radicación y trámite inicial.
- **31 a 90 días (Vencimiento Temprano):** Alerta de primer contacto de cobro persuasivo.
- **91 a 180 días (Vencimiento Medio):** Requiere conciliación de glosas y depuración de cuentas de difícil cobro.
- **181 a 360 días (Crítica):** Inicio de mesa de flujo de recursos o reporte a entes de control territorial.
- **Mayor a 360 días (Provisión de Cartera / Cobro Coercitivo):** Cuentas con alta probabilidad de deterioro.

B. Identificación de Concentración e Impacto Financiero

El sistema calcula automáticamente tres indicadores críticos para identificar a los actores del sistema de salud (EPS, Administradoras de Planes de Beneficios) de mayor impacto:

Variable de Análisis	Definición y Objetivo	KPI Asociado
Mayor Volumen de Facturación	EPS con la mayor cantidad de facturas radicadas (N° de transacciones). Permite medir la carga operativa de radicación.	Volumen de Emisión
Mayor Tasa de Glosa	Entidad con mayor porcentaje de objeciones frente a lo facturado. Facilita la detección de fallas en auditoría médica interna o pertinencia.	Tasa de Objeción (%)
Mayor Deuda Nominal	Entidad con el mayor saldo consolidado pendiente de pago, identificando el riesgo de iliquidez de la E.S.E.	Saldo Bruto Pendiente

2. Dashboard Unitario por Empresa y Trazabilidad (Gestión Activa)

Al hacer clic en cualquier entidad de salud (EPS Contributivo, Subsidiado o ARL), el sistema desplegará un panel de control específico para la vigencia actual que incluye:

- **Filtros Dinámicos:** Por estado de factura (Radicada, Auditada, Glosada en Conciliación, Aceptada, Cancelada).
- **Historial de Bitácora de Gestión (CRM de Cartera):** Un registro interactivo donde el analista alimenta las acciones de cobro realizadas (ej: "*Llamada a Coordinador de Cuentas Médicas, se acuerda mesa de conciliación para el día DD/MM*").
- **Alertas de Semáforo de Vencimiento:** Visualización gráfica basada en la fecha de radicación y los términos de pago de la Ley 1438 de 2011:
 - **VERDE** : 0 a 20 días desde la radicación (Dentro del término de ley de glosa/pago).
 - **AMARILLO** : 21 a 45 días (Plazo límite de respuesta de glosas o giro directo).
 - **ROJO** : Mayor a 45 días (Cuenta en mora, inicio de cobro persuasivo formal).

3. Tipologías Especiales de Cartera (No Prestación de Servicios de Salud)

Para evitar la distorsión de los indicadores de producción de servicios de salud, el sistema clasifica de forma independiente las carteras conexas que no corresponden a eventos de atención directa de usuarios:

1. **Cuotas Partes Pensionales:** Saldos pendientes por cobrar a otras entidades territoriales o fondos por concepto de la cuota parte del pasivo pensional de ex-empleados.
2. **Cobros Coactivos a EPS (Liquidación / Sanciones):** Cobros especiales derivados de procesos de compensación o recobros específicos.
3. **Arrendamiento de Espacios Físicos:** Facturación a terceros por alquiler de áreas de cafetería, consultorios satélites o antenas de telecomunicación dentro de la infraestructura de la E.S.E.

4. Ideas de Alto Valor Agregado (Propuestas por el Analista de Alto Nivel)

- **Módulo de Conciliación Masiva Automatizada:** Carga del archivo XML de glosas enviado por la EPS para cruzar automáticamente contra las facturas internas, reduciendo un 70% el trabajo operativo de digitación.
- **Previsión de Flujo de Caja (Cashflow Forecasting):** Análisis probabilístico de recaudo para los próximos 30, 60 y 90 días basado en el promedio histórico de pago de cada EPS y los aportes por Giro Directo de la ADRES.
- **Generador de Oficios Automáticos de Cobro Coercitivo:** Un botón que genera un PDF estructurado con la relación de facturas vencidas de una EPS específica, listo para firmas de control legal e institucional.